

Diabetes gestacional - rastreio e metas

DMG aumenta macrosomia, distocia e DM futuro. Rastreie no pré-natal, trate com terapia médica nutricional e inicie insulina se metas falharem.

Diagnóstico (conceito)

Dica - Diagnóstico (conceito)

TOTG 75 g: pontos de corte em jejum/1 h/2 h conforme IADPSG/MS. Um valor alterado já diagnostica em muitos protocolos.

Do TOTG no 2º trimestre ao reteste puerperal — a banca ama o follow-up.



Manejo

- Automonitorização; metas de jejum e pós-prandiais rigorosas
- Insulina é padrão se dieta insuficiente; metformina em protocolos selecionados
- USG para crescimento; atenção a polidrâmnio e macrosomia
- RN: risco de hipoglicemia neonatal — aleitamento precoce

Complicações

Momento | Risco

Fetal/neonatal | Macrosomia, hipoglicemia, icterícia

Parto | Distocia de ombro, laceração, cesárea

Materno | HAS/pré-eclâmpsia, infecção

Longo prazo | DM2 materno; obesidade na prole

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não 'liberar' sem reteste puerperal — muitas persistem com DM/intolerância. Hiperglicemia no 1º trimestre: pense DM prévio desconhecido, não só DMG.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Diabetes gestacional: rastreamento e diagnóstico — aqui usamos critérios IADPSG (TOTG 75 g) amplamente cobrados.

DMG - IADPSG (TOTG 75g)

1 valor alterado fecha diagnóstico

- 1 Jejum ≥ 92 mg/dL
- 2 1 hora ≥ 180 mg/dL
- 3 2 horas ≥ 153 mg/dL
- 4 Qualquer 1 ponto = DMG
- 5 Rastreio típico 24-28 semanas

Jejum ≥ 92 | 1h ≥ 180 | 2h ≥ 153 mg/dL

Rastreamento / diagnóstico (IADPSG)

Etapas | Conduta

1ª consulta | Glicemia de jejum: se muito alta, pensar DM prévio; se jejum 92–125 !' já pode fechar DMG (protocolo)

24–28 semanas | TOTG 75 g (jejum, 1 h, 2 h) — padrão IADPSG

Diagnóstico | "e 1 valor nos cortes IADPSG

Nota MS | Alguns serviços BR usam estratégia em 2 passos (50 g + 100 g); se a banca citar MS antigo, siga o enunciado

Critério usado neste pack

Dica - Critério usado neste pack

IADPSG / ADA one-step (TOTG 75 g). Cortes: jejum "e 92; 1 h "e 180; 2 h "e 153 mg/dL — um valor basta.

Conduta-ideia

- Dieta + atividade; automonitorização
- Insulina se metas não atingidas (metformina conforme protocolo/banca)
- Reavaliar no puerpério (TOTG 6–12 semanas) — risco de DM2

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1